



**INFORME DE
RESONANCIA MAGNÉTICA**

Centro: UNIDAD OSATEK
TXAGORRITXU
Dirección José Achótegui, s/n
(01009) VITORIA-GASTEIZ
Tel / Fax: 945007400 / 945007404
E-mail: rm.vitoria-gasteiz@osatek.es

Exploración: 26/09/2017 19:00: RM - CRANEAL
Radiólogo: GIL MARTIN, ANA ROSA

Apellidos: GUINEATBANEZ DE GARAYO
Nombre: LUIS MARIA
Id: 1164816
F. Nac.: 15/05/1956

N Prueba: VI001-02-107279
Procedencia: 10

Méd. Solicitante: NEUROLOGIA
ALVAREZ DE ARCAJA ESQUIDE
AMAIA ELENA

MOTIVO DE CONSULTA: Traumatismo craneoencefálico severo con fractura de base de cráneo, hematoma epidural temporal izquierdo, hematoma subdural temporoparietal izquierdo y HSA. Crisis comiciales. Valoración de secuelas.

TÉCNICA

Sagital T1, coronal TSE (T2), axial T2, FLAIR, DWI, T1 MPR y SWI. Estudio postgadolinio T1 axial MPR.

COMENTARIO

Cambios postquirúrgicos de Craniectomía frontoparietal izquierda con craneoplastia, sin aparentes datos de complicación.

Áreas de alteración de señal con hiperseñal en secuencias T2-Flair de localización subcortical frontoparietotemporal izquierdas, presentando alguna de ellas caída de señal en secuencias de susceptibilidad paramagnética en relación con componente hemorrágico (Hemosiderina), y que no muestran restricción en secuencias difusión ni condicionan efecto masa ni realzan tras introducción de gadolinio, sugestivas de áreas de aspecto gliótico residual postraumático, que condicionan moderada tracción - dilatación del asta ventricular ipsilateral.

Cavidad porencefálica de localización temporo basal izquierda hasta 2,5 cm de eje mayor, que presenta halo periférico hipointenso en secuencias de susceptibilidad paramagnética en relación con componente hemorrágico - Hemosiderina y asocia discreta alteración de señal del parénquima cerebral de la vecindad en probable relación con contusión intraparenquimatosa de aspecto residual. Dos pequeñas áreas subcentimétricas de hiperseñal de localización temporo basal derecha de aspecto gliótico residual probablemente origen postraumático.

Alguna pequeña lesión milimétrica hiperintensa en secuencias T2-FLAIR en sustancia blanca subcortical de localización frontal derecha que no muestra restricción en secuencias difusión ni condicionan efecto masa ni realza tras introducción de gadolinio, de características inespecíficas que puede corresponder con lesiones de carácter isquémico - Gliótico residual (a valorar en contexto FRCV del paciente).

No se evidencian lesiones isquémicas agudas ni subagudas.

No desviación de línea media.

Cisternas de la base permeables.

Charnela occipitovertebral normal.

No se evidencian LOES ni realces patológicos nivel supra - Infratentorial ni realces patológicos tras introducción de gadolinio.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

- Cambios postquirúrgicos de Craniectomía frontoparietal izquierda con craneoplastia, sin aparentes datos de complicación.
- Áreas alteración de señal de localización subcortical fronto-parieto-temporal izquierdas de aspecto gliótico residual y probable origen postraumático, algunas de ellas con componente hemorrágico de aspecto crónico - hemosiderina.
- Cavityd porencefálica de localización temporobasal derecha, relación con contusión intraparenquimatosa antigua.
- Alguna pequeña lesión milimétrica en sustancia blanca subcortical de localización frontal derecha que no muestra restricción secuencias difusión ni condicionan efecto masa ni realza tras introducción de gadolinio, de características inespecíficas que puede corresponder con lesiones de carácter isquémico - Gliótico residual (a valorar en contexto FRCV del paciente).
- No se evidencia lesiones isquémicas agudas ni subagudas.

Estado del informe VALIDADO / Doctor/a GIL MARTIN, ANA ROSA

Id: 1164816 N. Prueba: ¡Error! Elemento de Autotexto no definido.	Nombre: GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO, LUIS MARIA
Fecha informe : 30/09/17	

Pág. 2 de 2



Foro Parlamentario
Euzko Legebiltzarra
GOBIERNO VASCO